



Amina 18

Paciente de 18 años, bisexual, de origen bosnio, procedente de un entorno familiar muy unido y altamente simbiótico. Tiene una hermana gemela idéntica y una hermana menor, y cursa el último curso de una escuela secundaria de formación profesional (FOS). La familia sigue un estilo de crianza estricto y represivo, con escasa libertad para la toma de decisiones independientes. Los padres no aceptan las relaciones con personas de orígenes distintos al albanés, kosovar o bosnio. Tras un único episodio de consumo de cannabis, la paciente desarrolló intensos sentimientos de culpa y ansiedad debido al miedo a la reacción de sus padres. Los antecedentes familiares revelan un episodio depresivo en un pariente.

La paciente describe una imagen de sí misma muy negativa y se percibe a sí misma como «fea», «gorda» y «horrible». Entre las afecciones físicas preexistentes se incluyen la tiroiditis de Hashimoto (un trastorno crónico de la tiroides), así como la hipertensión. Cabe señalar que existe una correlación conocida entre los trastornos endocrinológicos y las enfermedades mentales, en particular la posible contribución del hipotiroidismo crónico al desarrollo de trastornos afectivos.

Se observan ataques de pánico comórbidos (F41.0), que pertenecen al grupo de trastornos neuróticos, relacionados con el estrés y somatoformes, clasificados en los códigos F40-F48.

Diagnóstico: F32.1 (G) Episodio depresivo moderado.

Síntomas: estado de ánimo depresivo persistente, baja autoestima, pérdida de motivación, pérdida de la libido, graves dificultades para conciliar el sueño y permanecer dormido, aumento y pérdida de peso rápidos y fluctuantes, descenso del rendimiento escolar, irritabilidad frecuente, pérdida de actividad, así como aislamiento social interno y externo

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com